Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Bronchospasme – Nébulisation

Adulte · enfant : dose du PAI ou du 15 · toute nébulisation est signalée au 15

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · ne peut plus parler, épuisement, cyanose, trouble de conscience ; SpO2 < 90 % malgré l'O2 ; FR < 10 ou > 25/min.

J'applique si

- Dyspnée avec **sibilants** (asthme, BPCO, bronchospasme).
- Avec ou sans désaturation.

Je n'applique pas → avis médical

- OAP suspecté ou douleur thoracique : **pas de salbutamol** sans avis du 15.
- Allergie connue, ou bronchospasme immédiat après inhalation.
- Ipratropium : jamais seul ; glaucome à angle fermé : embout buccal, éviter les yeux.

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **Demi-assis** ; O2 selon le protocole « Dyspnée / Désaturation – Oxygène ».
2. **Appeler le 15** : toute nébulisation lui est signalée.

SUR CE PROTOCOLE D'URGENCE

3. **1re nébulisation** (carte ci-contre) sous **O2 6–8 L/min**, 10 à 15 min.
4. BPCO : surveiller la vigilance pendant la nébulisation, puis lunettes, cible 88–92 %.

SUR ORDRE DU 15

5. Nébulisation suivante ; enfant : dose du PAI ou du 15.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Nébulisation (1re dose)

Adulte

Salbutamol 5 mg

+ Ipratropium 0,5 mg

NaCl 0,9 % qsp **5 mL**

Enfant (PAI ou 15)

- Salbutamol 50–150 µg/kg, max 5 mg (RCP) ; ipratropium 0,25 mg, qsp 4 mL

J'appelle le médecin

- Dyspnée nouvelle sans gravité ; fièvre et toux (pneumopathie ?).
- Besoin d'O2 persistant après la nébulisation.

Je surveille et je trace

- SpO2, FR, FC, conscience **toutes les 5 min**, pendant et après la nébulisation.
- Produits, doses, heure, débit d'O2, effet.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : Sibilants = nébulisation sous oxygène et appel au 15. Pas de salbutamol si OAP ou douleur thoracique sans avis du 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; arrêté du 26/06/2026 (art. 4 II : aérosols médicamenteux) ; RCP Ventoline 5 mg/2,5 mL nébul. (ANSM, MAJ 09/07/2024), Atrovent 0,5 mg/2 mL Adultes et 0,25 mg/2 mL Enfants (MAJ 19/03/2020) ; SRLF-SFMU oxygénothérapie 2024 ; outil chariot d'urgence DOTR (09/2026).

Réf. DOTR-IDE-NEB | Version 1.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature